

POTILASTIEDOT

Nimi Matti Virtanen
Ikä 64
Sukupuoli male

ALLERGIAT

- Penisilliini - diffuusi makulopapulaarinen ihottuma (dokumentoitu 2018)

KLIININEN HISTORIA

- Tunnettu hypertensio 5 vuoden ajan yhdellä verenpainelääkkeellä; verenpaineen hallinta ollut heikkoa viimeiset 12 kuukautta.
- Tyypin 2 diabetes diagnosoitu 8 vuotta sitten; metformiini 1000 mg kahdesti päivässä.
- Aktiivinen tupakoitsija (~30 askivuotta); aiemmin kieltäytynyt lopettamisesta.
- Ei aiempaa sydäninfarktia, aivohalvausta tai kroonista munuaissairautta.
- Isä kuoli äkilliseen sydänkuolemaan 60-vuotiaana.

LABORATORIOARVOT KOTIUTUKSESSA

- Troponin I.cardiac [Mass/volume] in Serum or Plasma: 14200 ng/L (< 14)
- Cholesterol [Mass/volume] in Serum or Plasma: 245 mg/dL (< 200)
- Cholesterol in LDL [Mass/volume] in Serum or Plasma: 160 mg/dL (< 100)
- Cholesterol in HDL [Mass/volume] in Serum or Plasma: 32 mg/dL (> 40)
- Hemoglobin A1c/Hemoglobin.total in Blood: 7.8 % (< 6,5)
- Creatinine [Mass/volume] in Serum or Plasma: 1.1 mg/dL (0,6-1,2)
- Glomerular filtration rate/1.73 sq M.predicted: 68 mL/min/1,73m² (> 60)
- Left ventricular Ejection fraction: 45 % (> 55)

SISÄÄNOTTO-DIAGNOOSI

Akuutti transmuraalinen anteriorinen ST-nousuinfarkti (STEMI)

SIVUDIAGNOOSIT

- Essentiaalinen hypertensio
- Tyypin 2 diabetes ilman komplikaatioita
- Sekamuotoinen hyperlipidemia
- Tupakointihäiriö (aktiivinen tupakoitsija, ~30 askivuotta)
- Suvussa esiintynyt varhaista sepelvaltimotautia

SUORITETUT TOIMENPITEET

- Primaari pallolaajennus (PCI) oikean rannevaltimon kautta
- Lääkestentti (DES) asennettu vasempaan etummaiseen laskevaan sepelvaltimoon (LAD) proksimaalisesti
- TIMI 3 -virtaus palautettu PCI:n jälkeen
- Kaksoisverihiutale-estolääkitys (DAPT) aloitettu (aspiriini + tikagrelori)
- Sydänkuntoutuksen vaihe I aloitettu ennen kotiutumista

SAIRAALASTA KOTIUTUMISEN YHTEENVETO

KLIININEN KERTOMUS

64-vuotias mies, tupakoitsija, jolla hypertensio ja tyypin 2 diabetes, saapui päivystykseen noin 90 minuuttia kestäneen voimakkaan rintalastan takaisen puristavan rintakivun vuoksi, joka säteili vasempaan yläraajaan. Lisäoireina esiintyi hikoilua ja etenevää hengenahdistusta vähäisessä rasituksessa. EKG:ssä todettiin ≥ 2 mm ST-nousu kytkennöissä V1-V4, mikä sopii akuuttiin anterioriseen ST-nousuinfarktiin. Potilas kuljetettiin päivystyksellisesti sydänkatetrointilaboratorioon. Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa todettiin vasemman etummaisen laskevan sepelvaltimon (LAD) proksimaaliosan 95% tromboottinen tukos. Potilaalle asennettiin onnistuneesti lääkeestentti ja TIMI 3 -virtaus palautui. Herkän troponiini I:n huippupitoisuus oli 14.200 ng/L. Toimenpiteen jälkeisessä transtorakaalisessa kaikututkimuksessa todettiin lievästi alentunut vasemman kammion ejektiofraktio (45%) ja etuseinämän sekä kammioväliseinämän hypokinesia. Kaksoisverihiutale-estolääkitystä jatkettiin. Potilas pysyi hemodynaamisesti vakaana, eikä rintakipua tai rytmihäiriöitä esiintynyt. Hänet kotiutettiin jäsennellyn kardiologisen seurannan ja sydänkuntoutusohjelman piiriin.

KOTIUTUSLÄÄKITYS

Lääke	Annos	Tarkoitus	Aikataulu
Acetylsalicylic acid	100 mg päivässä	Verihiutale-esto - estää verihiyytymiä	Aamulla
Ticagrelor	90 mg kahdesti päivässä	Verihiutale-esto - suojaa uutta stenttiä	Aamulla ja illalla
Atorvastatin	80 mg päivässä	Alentaa kolesterolia ja vakauttaa plakkeja	Illalla
Ramipril	2,5 mg päivässä	Suojaa sydäntä ja alentaa verenpainetta	Aamulla
Metoprolol	25 mg päivässä	Hidastaa sykettä ja suojaa sydäntä	Aamulla
Metformin	1000 mg kahdesti päivässä	Diabeteslääkityksen jatko	Aamulla ja illalla

SEURANTAOHJEET

Kardiologin vastaanotto 14 päivän kuluttua. Päivittäinen verenpaineen kotiseuranta. Tupakoinnin lopetusohjaus 7 päivän sisällä. Sydänkuntoutuksen vaihe II alkaa 3 viikon kuluttua. Lipidiprofiilin, HbA1c:n ja munuaisfunktion kontrolli 3 kuukauden kuluttua.

VAROITUSOIREET — SOITA 112 JOS:

- ! Yli 5 minuuttia kestävä rintakipu tai paineen tunne**
- ! Hengenahdistus levossa tai yöllinen paheneminen**
- ! Äkillinen huimaus, pyörtyminen tai lähes pyörtyminen**
- ! Äkillinen nilkkojen tai säärien turvotus**
- ! Verenvuoto, joka ei tyrehdy 10 minuutissa (verihiutale-estolääkityksen aikana)**
- ! Mikä tahansa uusi neurologinen oire (heikkous, puheen sammallus, näön menetys)**

SAIRAALASTA KOTIUTUMISEN YHTEENVETO

Syntheettinen ja anonymisoitu asiakirja HealthClarify-esittelyä varten. Ei ole todellinen lääketieteellinen asiakirja.